

1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: MARIA GABRIELA ECHEVERRIA MUÑOZ	H.C: 1077235980
EDAD: 13 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 16/10/2011
ESCOLARIDAD: Octavo Grado	FECHA DE EVALUACIÓN: 31,06/07/2025
DIRECCION: Cr 7 A # 16 - 50	CORREO: lletynna26@hotmail.com
EPS: Particular	SEXO: F
ACOMPAÑANTE: Madre	CELULAR: 3108651467
LATERALIDAD: Diestra	NEUROPSICÓLOGO EVALUADOR: M.G Jainer Guzmán USB Medellín
ESPECIALIDAD QUE REMITE: Psicología	

2. MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, “Ella me presento un ataque de pánico el jueves de la semana pasada, nunca lo había presentado y por consiguiente decidimos adoptar medida urgentes”.

3. ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde hace dos años caracterizado por dificultades en la comunicación asertiva entre la madre e hija, aparentemente es muy solitaria, poco expresiva en cuanto a las emociones, tiene amigos pero casi no tiene interacción física, interactúan con pantallas, agrega “más allá del colegio a partir de medios electrónicos”, no consume algunas verduras como zanahoria, habichuela, avena cuando tiene mucha hojuela, brócoli y coliflor cuando están hervido porque no tienen complemento, la paciente expresa que en ocasiones no le gusta la forma en la que se preparan estas verduras, le molestan algunos ruidos fuertes como el que se hace con el tenedor cuando se pasa sobre un plato de vidrio, la persistencia de un sonido puede saturarla, le molestan las luces parpadeantes, presenta rendimiento académico superlativo, a la fecha no se han referido quejas escolares, a pesar de que va bien, se subestima mucho, no logra reconocer las habilidades que tiene o que puede adquirir.

4. HISTORIA PERSONAL

PRENATALES: No embarazo previo, asistió a controles, embarazo sin riesgo, madre y padre no toman licor, no cigarrillo, no alucinógenos, adecuada alimentación, no auto medicación, no golpe abdominal o caída, no alteraciones en estado de ánimo, no enfermedades médicas.

PERINATALES: Embarazo a término de 39 semanas de gestación por cesárea, (no) utilización de fórceps, (no) maduración de pulmones en el útero, (no) hipoxia perinatal, no cianosis, (no) meconio, (no) sufrimiento fetal, (no) permaneció en incubadora.



5. DESARROLLO PSICOMOTOR

POSNATALES: Control cefálico 3 meses, rolado 4 meses, sentado 5 meses, gateo a los 8 meses, patrón recíproco, bipedestación 11 meses, marcha 12 meses, (si) reacción a los sonidos, (si) fijación de la mirada, lenguaje no funcional, no reporte peso al nacer kg, no reporte de talla.

6. ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción: No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

TDAH: No reporta

Esquizofrenia: No reporta

7. ANTECEDENTES PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: Alergias, dermatitis atópica, hipermetropía, astigmatismo. (Utiliza aditamentos - Lentes).

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

8. CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, inadecuada higiene postural, orientada a lo y auto psíquicamente, taquialia, taquipsiquia, ansiedad, distractiva, no alteraciones de sueño, no alteraciones o quejas de memoria, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conciencia, afecto plano, interés inusual en texturas.

9. PRUEBAS APLICADAS

Se realizó, escala de inteligencia de Wechsler para niños V: Atención, Claves del Wisc V, Búsqueda de símbolos del Wisc V: Memoria: Dígitos del Wisc V dígitos en orden directo, inverso y creciente, Span de dibujos del Wisc V, Lenguaje: Similitudes del Wisc V, Vocabulario, aritmética, letras y números. Se evaluó las funciones ejecutivas, aplicando el Wisconsin digital.

Se realiza prueba de observación del ADOS 2 que permita conocer la comunicación e interacción social, patrón de comportamiento restrictivo y repetitivo, socialización a partir de: tarea de construcción, juego simbólico, juego interactivo conjunto, tarea de demostración, descripción de una imagen, contar un cuento de un libro, viñetas, descanso, inventarse una historia, Lista de chequeo DSM 5 - Madre.





ESCALA DE INTELIGENCIA
DE WECHLER PARA NIÑOS - V

Cuadernillo de anotación

Cálculo de la
edad
cronológica

Año	Mes	Día
2025	7	31
2011	10	16
13	9	15

Nombre del niño: MARIA GABRIELA ECHEVERRIA MUÑOZ
Examinador: JAINER GUZMÁN VEGA

Fecha de aplicación
Fecha de nacimiento
Edad Cronológica

Página de resumen

Conversión de puntuaciones directas a puntuaciones escalares

Prueba	PD	Puntuación escolar				
Cubos	42		13			13
Semejanzas	39	15				15
Matrices	19			9		9
Dígitos	37				15	15
Claves	40					6
Vocabulario	42	14				14
Balanzas	27			13		13
Puzles visuales	21		12			(12)
Spam de dibujos	33				11	(11)
Búsqueda de Símbolos	22					7
Información	19					
Letras y números	23					
Cancelación	54					
Comprensión	25					
Aritmética	27					
Suma puntuaciones escalares		29	25	22	26	13
		Comp. Verbal	Visoes-pacial	Razon. Fluído	Mem. Trabajo	Vel. Proces.

Perfil de puntuaciones escalares

	Comprensión verbal				visoes-pacial		Razonamiento fluido			Memoria de Trabajo			Velocidad de Procesamiento		
	S	V	I	CO	C	PV	M	B	A	D	SD	LN	CL	BS	CA
	15	14	9	9	13	12	9	13	13	15	11	15	6	7	6
19															
18															
17															
16															
15															
14															
13															
12															
11															
10															
9															
8															
7															
6															
5															
4															
3															
2															
1															

Perfil de puntuaciones compuestas

	ICV	IVE	IRF	IMT	IVP	CIT
	124	114	106	117	80	116
160						
155						
150						
145						
140						
135						
130						
125						
120						
115						
110						
105						
100						
95						
90						
85						
80						
75						
70						
65						
60						
55						
50						
45						
40						

Conversión de suma de puntuaciones escalares a puntuaciones compuestas

Escala					
Suma punt. escalares	Puntuación compuesta		Rango Percentil	Intervalo de confianza	
				95%	
Comprension Verbal	29	ICV	124	95	113-130
Visoespacial	25	IVE	114	82	104-121
Razonamiento fluido	22	IRF	106	66	98-113
Memoria de trabajo	26	IMT	117	87	107-123
Velocidad de procesamiento	13	IVP	80	9	73-91
Escala total	85	CIT	116	86	109-121

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

Análisis Primario

Puntos fuertes y débiles						Punto fuerte o débil
		Puntuación	Puntuación de comparación	Diferencia	Valor crítico	
Índices	ICV	124	- 108,2	= 15,8	9,62	F o D
	IVE	114	- 108,2	= 5,8	10,7	F o D
	IRF	106	- 108,2	= -2,2	9,98	F o D
	IMT	117	- 108,2	= 8,8	9,62	F o D
	IVP	80	- 108,2	= -28,2	11,97	F o D
Pruebas	Semejanzas	15	- 11,5	= 3,5	2,86	F o D
	Vocabulario	14	- 11,5	= 2,5	2,94	F o D
	Cubos	13	- 11,5	= 1,5	3,46	F o D
	Puzles visuales	12	- 11,5	= 0,5	2,94	F o D
	Matrices	9	- 11,5	= -2,5	2,94	F o D
	Balanzas	13	- 11,5	= 1,5	2,68	F o D
	Dígitos	15	- 11,5	= 3,5	2,31	F o D
	Span de dibujos	11	- 11,5	= -0,5	3,03	F o D
	Claves	6	- 11,5	= -5,5	3,09	F o D
	Búsqueda de símbolos	7	- 11,5	= -4,5	4,08	F o D



Opciones de comparación de los índices

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones de los 5 índices primarios

MIP

541 / 5

108,2

Nivel de significación del valor crítico

Opciones de comparación de las pruebas

Puntuación de comparación

Suma de puntuaciones escalares de las 10 pruebas principales

MPE-P

115 / 10

11,5

Comparación entre índices/pruebas

Comparación		Puntuación 1	Puntuación 2	Diferencia	Valor crítico	Diferencia significativa
Índices	ICV-IVE	ICV 124	- IVE 114	= 10	11,28	S o N
	ICV-IRF	ICV 124	- IRF 106	= 18	10,72	S o N
	ICV-IMT	ICV 124	- IMT 117	= 7	10,44	S o N
	ICV-IVP	ICV 124	- IVP 80	= 44	12,30	S o N
	IVE-IRF	IVE 114	- IRF 106	= 8	11,54	S o N
	IVE-IMT	IVE 114	- IMT 117	= -3	11,28	S o N
	IVE-IVP	IVE 114	- IVP 80	= 34	13,02	S o N
	IRF-IMT	IRF 106	- IMT 117	= -11	10,72	S o N
	IRF-IVP	IRF 106	- IVP 80	= 26	12,54	S o N
	IMT-IVP	IMT 117	- IVP 80	= 37	12,30	S o N
Pruebas	Semejanzas-	S 15	- V 14	= 1	2,93	S o N
	Vocabulario					
	Cubos-	C 13	- PV 12	= 1	2,77	S o N
	Puzles visuales					
	Matrices-	M 9	- B 13	= -4	2,29	S o N
	Balanzas					
	Dígitos-	D 15	- SD 11	= 4	2,48	S o N
	Span de dibujos					
	Claves-	CL 6	- BS 7	= -1	3,04	S o N
	Búsqueda de símbolos					

Opciones de comparación de los índices

Nivel de significación del valor crítico

Grupo de referencia

Nivel de aptitud

Opciones de comparación de las pruebas

Nivel de significación del valor crítico

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS (WISC V)

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. Para obtener el CI total se utilizan siete de la diez pruebas (Cubos, semejanzas, matrices, dígitos, claves, vocabulario, balanzas). La paciente obtuvo un CIT de **116**, lo que la ubica en un rango por encima del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en CV es de **124**, se clasifica con una capacidad general **superior**, ubicándose dos rangos por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Lo cual representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, la experiencia educativa informal y formal, así como repertorios lingüísticos, manejo de analogías y análisis de relación.

Razonamiento visoespacial o perceptivo

El valor obtenido en RP es de **114**, se clasifica con una capacidad general **promedio alta**, ubicándola un rango por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de razonamiento perceptivo incluye el razonamiento espacial y la integración visomotora, procesos viso perceptuales y visos construccionales, así como razonamiento abstracto. De esta manera se identifican capacidades para analizar y sintetizar estímulos visuales, para categorizar, clasificar, dar juicios analógicos y razonamientos seriales dando cuenta de forma verbal.

Razonamiento fluido

El valor obtenido es de **106**, se clasifica con una capacidad general **promedio**, ubicándose dentro del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información, relaciones conceptuales subyacentes entre objetos visuales y usar el razonamiento inductivo y cuantitativo a fin de identificar y aplicar reglas.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en MT es de **117**, se clasifica con una capacidad general **promedio alta**, ubicándose un rango por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental; aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente.



Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en VP es de **80**, se clasifica con una capacidad general **promedio alta**, ubicándose un rango por encima del promedio esperado con relación con su edad escolar y grupo etario. En esta prueba se mide la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para parear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES

El análisis comparativo permite analizar si existen diferencias significativas entre diversos pares de índices y pruebas del análisis primario y secundario. Esto es importante porque las diferencias significativas merecen un estudio detallado con independencia de cuál sea la aptitud intelectual general de nuestra paciente.

Comparaciones entre índices primarios

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

NORMAL: Comprensión verbal < Razonamiento fluido: Implica fortalezas en las aptitudes fluidas respecto a las cristalizadas.

NORMAL: Comprensión verbal < Memoria de trabajo: Implica fortalezas en la capacidad de identificar y registrar información en la memoria a corto plazo sobre el uso de estímulos verbales para la resolución de problemas.

ANORMAL: Comprensión verbal < Velocidad de procesamiento: Indica punto débil en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto al uso de los estímulos verbales para resolver problemas.

NORMAL: Visoespacial < Velocidad de procesamiento: Refleja fortalezas en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a la capacidad de comprender y utilizar información visoperceptiva/visoespacial.

NORMAL: Razonamiento fluido < Velocidad de procesamiento: Sugiere capacidades esperadas en la velocidad para tomar decisiones utilizando información presente en la memoria a corto plazo respecto a las aptitudes para entender la relación entre la información visual y los conceptos abstractos.

ANORMAL: Memoria de trabajo < Velocidad de procesamiento: Establece bajas competencias en la toma de decisiones rápidas utilizando la información registrada en la memoria a corto plazo que en la manipulación de esta información.

Comparaciones entre índices secundarios: Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

NORMAL: Capacidad general < Competencia cognitiva: Indica que las aptitudes que favorecen la eficacia del procesamiento cognitivo (memoria de trabajo y velocidad de procesamiento) son un punto fuerte en comparación con las aptitudes cognitivas de nivel superior (comprensión verbal, procesamiento visoespacial y razonamiento fluido).

NORMAL: Memoria de trabajo < Memoria de trabajo auditiva: Se observó que la presentación verbal de la información establece un nivel adecuado en el funcionamiento de la memoria de trabajo respecto a la presentación visual.

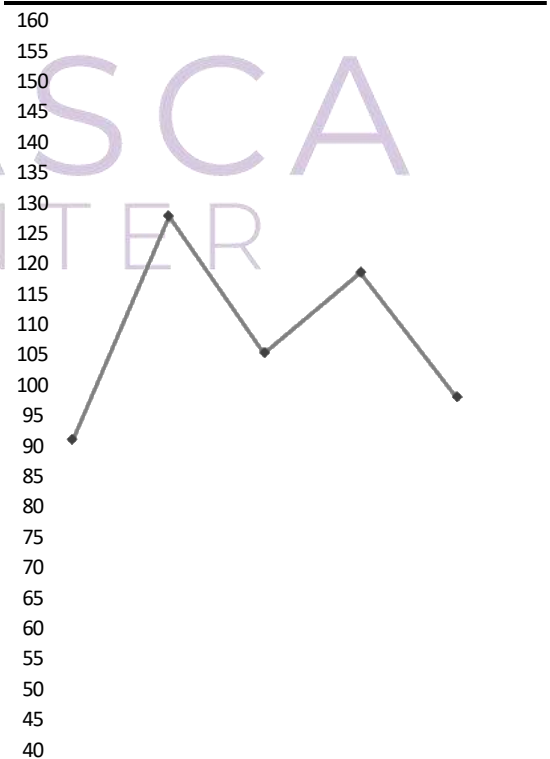


Análisis Secundario**Suma de puntuaciones escalares**

Pruebas	Puntuación escalar				
Cubos			13	13	
Semejanzas				15	
Matrices			9	9	
Dígitos		15			15
Claves			6		6
Vocabulario				14	
Balanzas	13		13	13	
Puzles visuales			12		
Span de dibujos			11		11
Búsqueda de símbolos					7
Letras y números		15			
Aritmética	13				
Suma de puntuaciones escalares	26	30	64	64	39
	Raz. Cuantitativo	Mem. Trabajo auditivo	No verbal	Capacidad General	Competencia Cognitiva



IRC	IMTA	INV	ICG	ICC
91	127	105	118	98

**Conversión de suma de puntuaciones escalares a índices**

Escala	Suma puntuaciones escalares	Índice		Rango Percentil	Intervalo de confianza
					95%
Razonamiento Cuantitativo	17	IRC	91	27	84-99
Memoria de trabajo auditiva	30	IMTA	127	96	117-132
No verbal	64	INV	105	63	99-111
Capacidad general	64	ICG	118	88	110-124
Competencia cognitiva	39	ICC	98	45	91-106

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com

INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES SECUNDARIOS

Razonamiento cuantitativo

El valor obtenido en IRC de 91 (entre 89-99) se sitúa en el percentil 27 y se clasifica como punto normal normativo / promedio con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de Razonamiento cuantitativo refleja la capacidad para realizar operaciones matemáticas mentalmente y comprender las relaciones cuantitativas. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió resolver mentalmente problemas aritméticos (Aritmética, Pe = 13) y en la otra se le pidió que observe una balanza a la cual le faltan pesas y seleccionar la opción que la mantiene equilibrada (Balanzas, Pe = 13). La variabilidad de los resultados en estas tareas no es representativa (es decir, su amplitud es menor a 5 puntos), punto fuerte normativo en este tipo de razonamiento.

Memoria de trabajo auditiva

El valor obtenido en IMTA de 127 (entre 117-132) se sitúa en el percentil 96 y se clasifica como Punto fuerte normativo / Superior con relación a otros niños de su edad y edad escolar.

El índice de Memoria de trabajo auditiva indica la aptitud para registrar, mantener y manipular información presentada verbalmente. Se ha evaluado mediante dos tareas: en la primera se le pidió repetir una lista de cifras en el mismo orden o en orden inverso (Dígitos, Pe = 15) y en la otra se le solicitó repetir una combinación de letras y números leída previamente por el/la entrevistador/a (Letras y números, Pe = 15). La diferencia de los resultados entre las dos tareas no es grande (no llega a los 5 puntos) y sugiere que el resultado en IMTA es una medida por encima del promedio en cuanto al desarrollo de memoria de trabajo auditiva.

No verbal

El valor obtenido en INV de 105 (entre 99-111) se sitúa en el percentil 63 y se clasifica como Punto normal normativo / Promedio con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice no verbal puede interpretarse como una medida de aptitud intelectual general que reduce al mínimo la intervención del lenguaje expresivo. El INV está conformado por 6 puntuaciones escalares de pruebas que no requieren respuestas verbales: cubos (Pe = 13), matrices (Pe = 9), claves (Pe = 6), balanzas (Pe = 13), puzles visuales (Pe = 12) y span de dibujos (Pe = 11). La variabilidad de los resultados en algunas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto débil normativo en este tipo de razonamiento.

Capacidad general

El valor obtenido en ICG de 118 (entre 110-124) se sitúa en el percentil 3 y se clasifica como Punto fuerte normativo / Promedio con relación a otros niños de su edad en la población normal.

El índice de capacidad general hace referencia a una estimación de la aptitud intelectual general menos dependiente de la memoria de trabajo y de la velocidad de procesamiento que el CI total. Involucra la capacidad de razonamiento abstracto y conceptual, razonamiento visoperceptivo y espacial y resolución de problemas verbales. El ICG es el resultado de 5 puntuaciones escalares: cubos (Pe = 13), semejanzas (Pe = 15), matrices (Pe = 9), vocabulario (Pe = 14) y balanzas (Pe = 13). La variabilidad de los resultados en estas tareas está dentro del promedio (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto fuerte normativo en este tipo de razonamiento.



Competencia cognitiva

El valor obtenido en ICC de 98 (entre 91-106) se sitúa en el percentil 45 y se clasifica como Normal/ Promedio con relación a otros niños de su edad y escolaridad.

El índice de competencia cognitiva ofrece una estimación de la eficacia con la que se procesa la información durante el aprendizaje, la resolución de problemas y el razonamiento de nivel superior. El ICC es el resultado de 4 puntuaciones escalares: dígitos (Pe = 615), claves (Pe = 6), span de dibujos (Pe = 11) y búsqueda de símbolos (Pe = 7). La variabilidad de los resultados en estas tareas es inusualmente grande (es decir, su amplitud es igual o mayor que 5 puntos), punto débil normativo en el desarrollo de algunas tareas pero no en el indicador general.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS PRUEBAS

Del cuadro de comparaciones entre puntuaciones se extraen diferencias significativas al 95% entre los siguientes pares de puntuaciones:

ANORMA: Cubos > Puzles visuales: Indica que el aprendizaje procedimental, la resolución de problemas por ensayo-error, el feedback visual concreto y/o la integración visomotora pueden mejorar el rendimiento en tareas en las que interviene el razonamiento visoperceptivo y espacial.

NORMAL: Matrices < Balanzas: Las actividades relacionadas con el razonamiento cuantitativo se establece como punto fuerte respecto al razonamiento inductivo.

ANORMAL: Claves < Búsqueda de símbolos: Sugiere que el rastreo visual poco efectivo es una fortaleza respecto a la memoria asociativa y/o la velocidad grafomotora.

NORMAL: Balanzas > Aritmética: Designa adecuadas respuestas de aptitud de razonamiento cuantitativo cuando el estímulo y la respuesta son visuales, en vez de verbales.

NORMAL: Retención de dígitos < Letras y números: Indica respuestas por encima del promedio con tareas que impliquen de ordenar cadenas largas de números.

Criterios cumplidos para el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo DSM 5 - Madre

Criterio a: Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes.

Algunas veces presenta:

Deficiencias en la reciprocidad socioemocional.

Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, comunicación integrada pasando por anomalías en el contacto visual.

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes.

Realiza frases idiosincrásicas, pensamiento rígido, insistía en la monotonía, permanente disprosodia.



ADOS

2

Autism Diagnostic Observation Schedule, Segunda EdiciónALGORITMO DIAGNÓSTICO: MODULO 3. FLUIDEZ VERBAL
NIÑOS Y ADOLESCENTES**Afectación social (AS)****Comunicación**

Narración de sucesos	(A-7)	1	1
Conversación	(A-8)	0	0
Gestos descriptivos, convencionales, instrumentales o informativos	(A-9)	1	1

Interacción social recíproca

Contacto visual inusual	(B-1)	2	0
Expresiones faciales dirigidas al examinador	(B-2)	1	1
Disfrute compartido durante la interacción	(B-4)	0	0
Características de las iniciaciones sociales	(B-7)	1	1
Calidad de respuesta social	(B-9)	1	1
Cantidad de comunicación social recíproca	(B-10)	1	1
Calidad general de la relación	(B-11)	1	1

TOTAL AS**7****Comportamiento restringido y repetitivo (CRR)****Comportamientos restringidos y repetitivos**

Uso estereotipado o idiosincrásico de palabras o frases	(A-4)	1	1
Interés sensorial inusual en los materiales de juego o en las personas	(D-1)	1	1
Manierismo de manos y dedos y otros manierismos complejos	(D-2)	0	0
Intereses excesivos en temas u objetos inusuales o altamente específicos	(D-4)	0	0

TOTAL CRR**2****PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL (AS + CRR)****9**

CENTRO ESPECIALIZADO DE PSICOLOGÍA, ASISTENCIA INTEGRAL Y REHABILITACIÓN

DIR: CALLE 11 # 11 – 07 BARRIO SAN JOAQUÍN LOCAL 102

CONTACTOS: 312 567 8078 – prascacenter@gmail.com



CONVERSIÓN DE LA PUNTUACIÓN TOTAL GLOBAL AL RANGO DE PREOCUPACIÓN DEL ADOS-2	
Rango de preocupación	Puntos de corte
Rango Cuantitativo	9
Rango Cualitativo	Autismo

Proporciona suficiente información de un hecho rutinario (p. ej., jugar a su juego preferido; compartir con amigos, la rutina de regresar a casa después de la escuela), que no es parte de una preocupación o de un interés marcado y pareciera ser real. Da información sin necesitar preguntas específicas pero con poca expresión de los gestos faciales que deben estar acompañando la expresión oral, puede necesitar que inicialmente se le pida que describa el suceso para poder elaborarlo.

La conversación fluye, construyéndose sobre el diálogo del examinador pero de forma rígida por momentos pero elaborada con disprosodia o acento particular que no se ajusta a las regiones donde ha vivido si no que parece mas bien un lenguaje de personaje de caricatura.

Es capaz de hacer uso espontáneo de gestos descriptivos, pero exagerados, poco variados o que se producen en pocos contextos (p. ej., como ocurrió en la la "Tarea de demostración"), como cepillado, contar una historia, logra referir historias pero que ha creado meses anteriores o que pertenecen a un programa o historia, reconoce que se le dificulta imaginar a pesar de tener alta habilidad para el dibujo. Las expresiones faciales se relacionan con la hiponimia o poca expresión afectiva de las emociones, manteniendo un comportamiento social permanente que poco varia con las contingencias ambientales que pueden oscilar de la rigidez y angustia extrema como manifestaciones de conductas ansiosas.

Establece un contacto visual modulado pobremente para iniciar, terminar o regular una interacción social, es decir que puede hacer contacto visual pero no permanente, sugiere que es una forma de mantener el control.

Le cuesta mantener una conversación de un tema que no sea de su interés, le cuesta hacer preguntas para mantener una conversación fluida, responde lo que se le pregunta y puede seguir el hilo, pero siempre se debe estar encaminado la conversación, le cuesta contar cosas específicas que se relacionan con sus amigos que no incluyen de forma particular a la familia como lo haría una adolescente de su misma edad, por ejemplo puede captar, mantener o dirigir la atención del examinador pero no de manera frecuente.

El uso de palabras o frases tienden a repetirse como expresiones como umm, antes de iniciar una conversación aunque no de forma contingente, sus expresiones suelen ser formal que en la mayoría de las



personas con el mismo nivel de lenguaje expresivo, pero claramente raro; emplea palabras o frases de una manera inusual, también junto con un considerable lenguaje espontáneo flexible; la paciente manifiesta tener dificultades para relacionarse aunque intenta ser sociable, en ocasiones le cuesta reconocer las altas capacidades que presenta, lo cual se pudo agudizar por antecedente de matoneo, tiene una tendencia hacer inocente

Se observó durante todas las sesiones un interés inusual por objetos relacionados con alto nivel sensorial como por ejemplo tocar juguete propioceptivo de forma permanente, por ejemplo en los antecedentes que se profundizó en evaluación la paciente expresó que le molestan los ruidos intensos como el sonido que se hace con un tenedor sobre un plato de vidrio, no consume algunas verduras como zanahoria, habichuela, avena cuando tiene mucha hojuela, brócoli y coliflor cuando están hervido porque no tienen complemento, la paciente expresa que en ocasiones no le gusta la forma en la que se preparan estas verduras, (no le gusta la presentación o como percibe la textura de esos elementos), le molestan las luces parpadeantes, ruidos repetitivos, de forma que pueden hacer que se ubique en otros lugares.

Evaluación Neuropsicológica Funciones ejecutivas

PRUEBA DE CLASIFICACIÓN DE WISCONSIN		
Evalúa el razonamiento abstracto, estrategias de solución de problemas necesarias para lograr un objetivo, funciones ejecutivas, cambio de tarea, la flexibilidad cognitiva, la actualización, la inhibición, la planificación o la fluidez, mantenimiento del principio.		
Puntuación	Media	indicador
6	5,8 SD 0,7	Normal
Normal, pero con perseveraciones y fallas atencionales que le generan problemas para mantener el principio y la atención en la tarea.		



WCSTw: Resultados

Indica "nº ítem: tecla pulsada/Acierto(+) o Error(-)/Respuesta según Color, Forma,..."

W.C.S.T. A. Estévez-González, 2001

1: 1/-/FN-/	33: 3/+/-/N-/	65: 1/+/-/FN-/	97: */*/
2: 4/-/N-/p	34: 4/+/-/N-/	66: 3/-/F-/	98: */*/
3: 1/-/F-/	35: 1/+/-/N-/	67: 2/+/-/N-/	99: */*/
4: 1/+/-/CN-/	36: 4/+/-/N-/	68: 1/+/-/CN-/	100: */*/
5: 2/+/-/CF-/	37: 2/+/-/N-/	69: 4/+/-/N-/	101: */*/
6: 3/+/-/CF-/	38: 3/+/-/CN-/	70: 1/+/-/N-/	102: */*/
7: 4/+/-/CN-/	39: 1/+/-/N-/	71: 4/+/-/CN-/	103: */*/
8: 4/-/F-/	40: 4/+/-/CN-/	72: 3/+/-/N-/	104: */*/
9: 3/-/F-/	41: 1/+/-/CFN/	73: 4/+/-/N-/	105: */*/
10: 3/+/-/C-/	42: 3/+/-/N-/	74: 2/+/-/N-/	106: */*/
11: 4/+/-/C-/	43: 4/-/FN-/	75: 1/+/-/N-/	107: */*/
12: 1/+/-/CF-/	44: 2/+/-/CN-/	76: 3/+/-/N-/	108: */*/
13: 4/+/-/C-/	45: 1/+/-/C-/	77: */*/	109: */*/
14: 3/+/-/C-/	46: 3/+/-/CF-/	78: */*/	110: */*/
15: 2/+/-/C-/	47: 4/+/-/CF-/	79: */*/	111: */*/
16: 4/+/-/CFN/	48: 3/+/-/CN-/	80: */*/	112: */*/
17: 1/+/-/C-/	49: 2/+/-/CN-/	81: */*/	113: */*/
18: 3/+/-/CN-/	50: 3/+/-/C-/	82: */*/	114: */*/
19: 1/+/-/CF-/	51: 4/+/-/C-/	83: */*/	115: */*/
20: 3/-/C-/	52: 2/+/-/CF-/	84: */*/	116: */*/
21: 2/+/-/FN-/	53: 1/+/-/C-/	85: */*/	117: */*/
22: 3/+/-/FN-/	54: 2/-/C-/	86: */*/	118: */*/
23: 2/+/-/FN-/	55: 3/+/-/F-/	87: */*/	119: */*/
24: 1/+/-/F-/	56: 4/+/-/F-/	88: */*/	120: */*/
25: 2/+/-/F-/	57: 3/+/-/F-/	89: */*/	121: */*/
26: 1/+/-/F-/	58: 1/+/-/FN-/	90: */*/	122: */*/
27: 3/+/-/FN-/	59: 3/+/-/FN-/	91: */*/	123: */*/
28: 4/+/-/FN-/	60: 4/+/-/F-/	92: */*/	124: */*/
29: 2/+/-/CFN/	61: 2/+/-/F-/	93: */*/	125: */*/
30: 3/+/-/F-/	62: 3/+/-/CFN/	94: */*/	126: */*/
31: 4/+/-/FN-/	63: 1/+/-/CF-/	95: */*/	127: */*/
32: 2/-/CF-/	64: 3/+/-/F-/	96: */*/	128: */*/

Datos Personales

MARIA GABRIELA ECHEVERRIA MUÑOZ

Fecha : 31/07/25

Sexo : f

Edad : 13 años

Lateralidad : Diestro/a

Escolaridad: 8 años

Observaciones no especificadas

Resultados

INTENTOS Utilizados.....: 76

ACIERTOS Totales.....: 66

ERRORES Totales.....: 10 (13%)

Errores Perseverativos...: 1 (1%)

Errores NoPerseverativos: 9 (11%)

Respuestas Conceptuales : 66 (86%)

CATEGORIAS.....: 6

Nº Intentos 1ª categoría: 19

Errores Manten. del Set : 0

Aprendiendo a Aprender : 3

Tiempo medio respuesta : 5850 msec.

Características de la prueba

WCST clásico con secuencia CFND

Nº Estímulos Prueba : 128

Imprimir Grabar Finalizar

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

RESULTADOS DE EVALUACIÓN:

ORIENTACIÓN: Adecuada orientación auto y alopsíquica.

ATENCIÓN: Presenta un desempeño adecuado en la atención focalizada, sostenida, selectiva (no distractiva) acorde a su edad y escolaridad, la atención focalizada le permite mantenerse en un estímulo relevante independientemente del tiempo, la atención sostenida le permite la capacidad de mantener el foco en una actividad o estímulo durante un tiempo determinado, la atención selectiva le permite establecer la capacidad de focalizar la mente en un estímulo o una tarea concreta, sin permitir que otros estímulos interrumpan lo que se está haciendo.

Presenta adecuada atención auditiva, adecuada búsqueda organizada de los estímulos, aunque con una



incorrecta velocidad en la ejecución de tareas que se deben ejecutar en un tiempo específico.

Paciente con adecuada capacidad de esfuerzo en la ejecución de tareas no motivantes, prestando atención a los detalles, se esfuerza y dirige la conducta, inhibiendo los estímulos irrelevantes, mantiene la concentración aun cuando el grado de la tarea aumenta, es capaz de regular su comportamiento, mantener una adecuada posición sedente, no se observa agitación motora, impulsividad (atención ejecutiva).

MEMORIA: Presenta adecuada memoria ecoica e icónica, la memoria de trabajo presenta un desempeño normal acorde a lo esperado para la edad y escolaridad. Esto quiere decir, que existe adecuada capacidad para mantener una información y dar una respuesta posterior; sin embargo, puede verse afectada en caso de que tenga un mayor esfuerzo cognitivo relacionado con el control mental y capacidad atencional.

Se identifica adecuada capacidad para evocar información a corto y largo plazo de contenido auditivo verbal y visual de forma organizada, con altas capacidades en los procesos de codificación, decodificación y evocación estableciendo un alto aprendizaje significativo, por encima de su edad y escolaridad.

Su capacidad de memoria o spam es de 12 sobre 10, observándose de forma correcta el efecto de primacía y recencia, no se observaron intrusiones, perseveraciones, con adecuada organización serial.

LENGUAJE: Existe adecuada capacidad semántica, de vocabulario, de información, existe adecuado seguimiento de instrucciones, comprensión manteniendo una comunicación efectiva comprendiendo el mundo que les rodea, adecuada fluencia lingüística en la producción oral.

No se observaron problemas articulatorios, nasalización, hipofonia, parafasias semánticas, fonológicas o visuales.

Clínicamente se observó disprosodia – acento particular que no se ajusta al contexto, dice expresiones con ummm.

PRAXIAS VISO CONSTRUCCIONALES: Se identifica nivel normal para la edad y escolaridad en lo que se refiere a la copia de modelos a través del sistema grafo motor, coordinación viso motora y proceso viso perceptuales. No se observa dificultad en el proceso para el manejo de proporciones, detalles de la imagen, integración de los elementos, exactitud, sin omisión de los elementos.

GNOSIAS: No se observan alteraciones en el reconocimiento de la información previamente aprendida a través de nuestros sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto.

FUNCIONES EJECUTIVAS: Cribada con adecuada capacidad en control atencional, algunas fallas en regulación conductual, inhibición, adecuados procesos de análisis e inferencia, semejanzas, calculo, adecuada planeación y ejecución de acciones, adecuado seguimiento de secuencia, organización de la conducta, adecuada capacidad para la generación de estrategias y procesos de meta cognición, así como insight, pensamiento rígido y poco flexible con fijaciones particulares aunque no alcanza la desviación estándar.

Paciente con **CIT de 116**, lo que lo ubica en un rango de acuerdo con el WISC V con **capacidad general intelectual promedia alta**, sin embargo, las bajas puntuaciones en comprensión verbal, razonamiento perceptivo, razonamiento fluido, memoria de trabajo, y velocidad de procesamiento, las conductas



desadaptativas, comportamiento disruptivo, poca regulación e inhibición del impulso, establecen la necesidad de apoyo, monitoreo y supervisión permanente en el desarrollo de sus tareas, estableciendo la necesidad de adecuación y adaptación curricular en las aulas escolares.

Este cociente intelectual significa que existe facilidad para razonar, pensar, hacer análisis, inferencia, crítica, realizar lógica, con alta fluidez verbal semántica y fonológica, capacidad para mantener información a corto plazo y en línea, dar una respuesta inmediata; adecuada consciencia fonológica, comprensión, organización perceptual y habilidades viso espaciales, facilidad para la planificación y memoria de trabajo, capacidad de establecer relaciones espaciales y la coordinación viso motriz, praxicas, capacidad de abstracción, formación de conceptos, mantenimiento y cambio de estrategias cognitivas.

Las altas puntuaciones en los indicadores de comprensión verbal, razonamiento perceptivo, las adecuadas puntuaciones en razonamiento fluido, memoria de trabajo, establecen una alta facilidad para la adquisición de nuevos aprendizajes y procesos de memoria a largo plazo.

Se observa un desarrollo por encima de lo esperado de la capacidad cognoscitiva en la comprensión verbal 124 y habilidades visoespaciales de 114, lo cual establece un adecuado desarrollo del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.

Se observan respuestas dentro del promedio esperado en cuanto al procesamiento de la información con sus recursos innatos, del indicador de razonamiento fluido. 106, lo que facilita en la paciente la capacidad de resolver nuevos problemas de forma inmediata, es decir, de forma instintiva y con destreza.

La memoria de trabajo, 117, se encuentran un rango por encima del promedio, facilitando el manejo de la información a corto, plazo, en línea, siendo un punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

La velocidad de procesamiento, 80, se encuentran en un rango por debajo al promedio esperado, lo que puede establecer dificultades en las respuestas de forma rápida, efectiva y con interferencia, punto débil normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

Perfil del paciente:

Según la aplicación de las pruebas y observación clínica se obtiene un perfil de paciente con CI promedio alto (116), con alta capacidad en comprensión verbal y habilidades visoespaciales, adecuada capacidad para el aprendizaje – razonamiento fluido, alta capacidad para la codificación, decodificación y evocación, alta habilidad en memoria de trabajo, con bajas respuestas en velocidad de procesamiento, lo que significa que tarda un poco mas de lo esperado en ejecutar algunas tareas, con alto riesgo para síndrome asperger desde la cie 10, equivalente al trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo Intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje desde la CIE 11, con nivel de apoyo 1, con altas capacidades, observándose dificultades en las áreas de comunicación social e interacción reciproca: Dificultades en las iniciaciones social de manera espontánea con personas de su grupo etario, por momentos siente que no encaja, se siente incomprendida, no reconociendo las fortalezas, disprosodia – habla con acento particular y caricaturesca seguido de expresiones antes de comenzar hablar como ummmm, hiporeactividad – fijación sensorial inusual por algunos objetos, no le gusta que tomen sus cosas – el grado de afectación no se explica como un parámetro normal de comportamiento, le gusta mantener el control, algunas



manifestaciones ansiosas cuando pierde el control o se siente presionada, selectividad a alimentos, aunque de baja frecuencia, poca flexibilidad, pensamiento rígido, poco contacto visual, hiponimia – afecto plano, dificultades para mantener una narrativa aunque puede responder preguntas y establecer temas de conversación, dificultades en la reciprocidad socioemocional, intereses particulares, dificultades en las relaciones sociales con pares, tiene un estilo de comunicación que se desvía de los patrones normales, con un lenguaje formal, adornado, mecánico, pocas veces ofrece información de manera espontánea sobre sus propios pensamientos, sentimientos o experiencias, responde adecuadamente a los comentarios hechos por el examinador acerca de sus pensamientos, sentimientos o experiencias, pero no hace preguntas sobre ellos, proporciona información acerca de hechos rutinarios o no rutinarios, pero depende de las preguntas específicas del examinador para poder continuar; parte del habla de la evaluada incluye elaboración espontánea de sus propias respuestas para el beneficio del examinador; o da pie a que el examinador pueda seguir la conversación, pero la cantidad de habla es menor a la esperada para el nivel de lenguaje expresivo del evaluado o bien es limitada en cuanto a su flexibilidad, esto significa que no existe fluidez, lo que se quiere decir es que le cuesta ser espontáneo, creativo, con pocos gestos corporales y contacto visual a la hora de establecer una conversación que no se relacione con gustos o intereses personales.

Muestra disfrute adecuado al contexto durante las interacciones con el examinador, muestra ejemplos de comprensión de varias relaciones sociales típicas pero no de su propio papel en ellas; iniciaciones sociales con características ligeramente inusuales, realiza intentos de captar, mantener o dirigir la atención del examinador, incluyendo iniciaciones relacionadas únicamente con preocupaciones, acciona a la mayoría de los contextos sociales. pero de forma algo limitada, le cuesta realizar un intercambio social (esto es. charlar, hacer observaciones o tener comportamientos no verbales que parecen tener una intención de reciprocidad), pudiendo afectar sobre todo las relaciones interpersonales, entender las diferentes perspectiva – vida social, personal y familiar.

COMPRESIÓN VERBAL: POR ENCIMA DE LO ESPERADO

VISOESPACIAL: POR ENCIMA DE LO ESPERADO

RAZONAMIENTO FLUIDO: PROMEDIO

MEMORIA DE TRABAJO: POR ENCIMA DE LO ESPERADO

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

CIE 10 F845 SÍNDROME DE ASPERGER (Nivel de apoyo grado 1 – DSM 5) acompañado de altas capacidades, CIE 11 - 6 A02.0 Trastorno del Espectro del Autismo sin Trastorno del Desarrollo Intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje.

CIT DE 116, CAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL MEDIA ALTA, ALTAS CAPACIDADES.



PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por dos meses para fortalecer los procesos cognitivos para mejorar la velocidad de procesamiento, flexibilidad, espontaneidad, interacción, disprosodia, pensamiento rígido, comprensión de las altas capacidades.

Rehabilitación dos veces por semana por tiempo de 6 meses desde psicología que permita abordar seguridad, confianza, manejo de la frustración, ansiedad – ataques de pánicos, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, razonamiento ético; adopción de perspectiva, desarrollo de asertividad; inoculación de estrés; auto instrucciones; habilidades de afrontamiento; autocontrol y control emocional; cognitivo-conductuales educación afectiva; entrenamiento en habilidades sociales.

Vincular a los padres mediante psicoeducación y sensibilización, como acompañamiento de la menor en sus dificultades, y orientarla en el manejo de estas.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos de biorritmo y habilidades sociales.

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Proporciónale tareas más complejas o proyectos que estimulen su pensamiento crítico y creatividad.

Bríndale oportunidades para explorar temas de su interés y trabajar de manera independiente cuando sea apropiado.

Anima a que profundice en los temas, en lugar de solo memorizar información, promoviendo el análisis y la reflexión.

Integra actividades que desafíen su nivel, como debates, investigaciones o proyectos innovadores, no la presione, no la minimice, resalta lo positivo.



Reconoce sus logros y ayúdale a gestionar posibles sentimientos de aburrimiento o frustración si no encuentra suficiente estímulo.

Esto puede ayudarle a desarrollar habilidades sociales y a compartir ideas con pares que tengan intereses similares – por favor psicoeduque a los otros niños la integren cuando se asile con amor.

Trabaja con docentes especializados en educación para altas capacidades, si está disponible, para diseñar estrategias personalizadas.

Dar un trato digno.

Las asignaturas deben tener la suficiente didáctica para captar la atención de la estudiante.

Necesidad de orientación educativa.

Implementar metodología de aprendizaje personalizado y acordes a sus capacidades.

Es importante verificar si desde su asignatura comprendido la explicación, la intrusión, etc.

Promueva la motivación permanente con puntos extras.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos manipulativos y habilidades sociales.

Trate de comprender el comportamiento, no se lo tome personal, está aprendiendo regularse.

Utilice un lenguaje claro, mensaje corto y apoyo en lo visual y auditivo.

Establezca rutinas claras, cronogramas visibles donde el aprenda que se debe hacer y cómo comportarse.

Dele un poco más de tiempo para las tareas.

Refuerce las conductas positivas.

Siente cerca al docente.

Permítale de vez en cuando salir a despejarse, no se tome su comportamiento personal, es algo que no puede evitar, enséñele con amor a regularse.

Tenga en cuenta que existen problemas de autoestima, fomente un entorno de seguridad y confianza y no de señalamientos.



Haga del lugar de clases un lugar seguro, armonioso donde se sienta protegida, querida, celebre los pequeños logros.

Evite criticar su comportamiento, anímela, no se lo tome personal.

Coloque actividades de monitorea.

No permita que le hagan matoneo, esto puede desfavorecer la autoestima, la interacción.



Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M.G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional: 123096

Certificado internacional en ADOS 2

PRASCA
CENTER

